



リポイド肺炎 lipoid pneumonia

到達目標

- リポイド肺炎の定義，病態が理解できる
- 診断における気道由来サンプルの脂肪貪食マクロファージの意義を説明できる
- 原因によって症状，対処法，予後が異なることを理解できる

定義

脂質を貪食したマクロファージが肺胞腔内に出現することを特徴とする化学性肺炎である。これは内因性 (endogenous) と外因性 (exogenous) に分類されるが、一般的には、オイルのような油脂類を誤嚥・吸入して発症する外因性のものをリポイド肺炎という。内因性リポイド肺炎は気道閉塞部位遠位の障害された肺胞壁から逸脱した脂質や、気道悪性腫瘍や化膿性病変による肺組織障害でみられ、コレステロール肺炎と呼ばれることがある。まれではあるが、内因性リポイド肺炎は脂肪塞栓症，血栓塞栓症，多発血管炎性肉芽腫症，肺胞蛋白症などにより発生することもある。

病因・病態・疫学

a 頻度

化学性肺炎のひとつであるが，まれな疾患であり，診断が難しい。剖検例で，約1～2.5%という報告がある¹⁾。

b 原因

外因性リポイド肺炎の原因は，海外では緩下剤として処方された流動パラフィンの慢性的な誤嚥による報告が最も多い。胃食道逆流，精神疾患などが本症の誘因となる。流動パラフィンは無色透明の液状物質で，誤嚥しても低刺激性のため声門閉鎖や咳反射が起こりにくく，肺炎に至る。日本では流動パラフィンを緩下剤として，使用することが少ないためこうした報告は限られており，油脂類の accidental な誤嚥・吸入による症例が多い。ガソリンや灯油を扱う職場の人，鋳物の取扱者，中華料理人などで発症する場合がある。

c 病態

外因性リポイド肺炎では油脂の種類，化学的性状，量などによって肺組織障害の程度が異なる。動物性油脂はリパーゼで加水分解されて遊離脂肪酸を生成するため，植物性油脂に比べ組織損傷が大きく，壊死性出血性肺炎を招く場合がある。殺虫剤などに含まれる鉱物油であれば，通常は組織反応は軽度であるが，大量に吸入した場合は急性の炎症，血管障害により壊死性出血性肺炎や肺化膿症を発症する場合がある。

症候・身体所見

誤嚥や吸入曝露の程度にもよるが，症状は軽微で，約4割は無症状という報告がある²⁾。発熱，咳嗽，呼吸困難，胸痛，咯血がみられる場合がある。慢性例では，体重減少がみられる場合がある。

診断・検査

a 画像所見

誤嚥，吸入物質の性状，量，期間などにもよるが，胸部CT像では肺泡性陰影，間質性陰影，結節性陰影など，さまざまな陰影を呈しうる。肺門リンパ節腫大や胸膜病変を認めることもある。病変の分布に関しても区域性もしくは大葉性，片側性もしくは両側性と多様な報告があり，下葉もしくは右中葉が多いとされる³⁾。急性発症例は，胸水貯留を伴うことが多く，慢性リポイド肺炎では，腫瘤影を呈する場合がある¹⁾。

b 診断

診断は，吸入，誤嚥などの病歴の確認と喀痰や経気管支肺生検 (transbronchial lung biopsy : TBLB) などで気道から採取した検体で脂肪を貪食したマクロファージを同定することである。

c 病理組織所見

病理組織学的所見としては，誤嚥，吸入部位に一致した出血性肺炎，脂肪を貪食した肺胞マクロファージや形質細胞の集積，肺胞壁の破壊と線維化がみられる。

治療と予後

a 治療

症状が軽微で治療を必要としない場合もある。発症していても，確立した治療のエビデンスは乏しい。職業性吸入曝露で生じたものでは，誘発因子の吸入を避けることが必要である。治療の主体は対症療法で，必要であれば酸素投与を行い，場合によっては，気管支肺胞洗浄などによる肺胞内脂質の除去を検討する。びまん性リポイド肺炎症例では全肺洗浄が有用であったとの報告がある⁴⁾。油脂の誤嚥や吸入曝露後に細菌感染が生じている場合は，抗菌薬治療を行う。ステロイド投与が有効との報告もある⁵⁾が，治療の有効性は確立していない。

b 予後

診断が困難な症例が多く，一般的な予後は不明であるが，一般的に無症状例も含め急性型の予後はよいと考えられている。慢性型についても反復する感染症として診断されていない症例もある一方で，慢性に原因